

Información Paciente			N° Epicrisis	
Nombre	: Victor Antonio Aravena Ahumada	Rut	: 6.599.334-1	N° Archivo : 0626203
Edad	: 72a 0m 30d	Fecha Nacto:	12/08/1952	Sexo : Masculino
Dirección	: 3 Oriente 8015	Comuna	: La Granja	Teléfono : 9 7904 4923

Información Hospitalización				Días Estadía: 6
Unidad de Ingreso	: Upc - Uci Adulto	Fecha Ingreso	: 05/09/2024 16:28	
Unidad de Egreso	: Upc - Uci Adulto	Fecha Egreso	: 11/09/2024 20:09	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso
Hemorragia digestiva alta

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Victor Aravena Ahumada
72 años
FI CASR: 05/09/24
FI UPC: 06/09/24

Motivo ingreso: compromiso de conciencia

AM: DHC CP A, diciembre 2022 HCC segmento IV 5 cm, ablación por laparoscopia puente, AFP(-). En marzo 2024 RNM: 2 nuevas lesiones lobulos hepáticos izquierdo y EE segmento IV. AFP(-)-> en espera de nueva RNM de abdomen, con plan de si mantiene igual carga de enfermedad SBRT segmento IV y TACE a las otras 2 lesiones.

DM-NIR, HTA, usuario de NACO (rivaroxaban) por trombosis de arteria hepática
ECOG: 0

En diciembre 2022 HCC segmento IV 5 cm, ablación por laparoscopia puente, AFP (-)

En marzo 2024 RM: 2 nuevas lesiones lóbulo hepático izquierdo y EE segmento IV. AFP (-)

- Quirurgicos: ablación laparoscópica de hepatocarcinoma (2022) Amputacion traumática dedos mano derecha

- Farmacos: TACO con Rivaroxaban (junio 2024); carvedilol 3.125 cada 12, omeprazol, espironolactona 50, Ac. fólico, metformina 850, fierro.

-Alergias: (-)

-Hábitos: TBQ(-) , OH(-) , Drogas (-)

-Social:

- Examen relevante (cardiológico) : ECO TT BASAL 1. VI de tamaño normal, con función sistólica global normal por FE 57%, sin defectos segmentarios. Llenado normal. 2. VD de tamaño y función normal. 3. Sin evidencia de shunt en la prueba de SF agitada. CONCLUSIONES ECO ESTRES 1. Ecocardiograma con estrés Dobutamina insuficiente para evaluar isquemia. 2. Extrasistolía ventricular compleja en el peak de infusión (motivo de suspensión de la prueba) ECG: RITMO SINUSAL, AQRS - 10, PR 120, QRS 80, QT 320, ST-T T NEG DIII FC 78 Evaluación por cardio: PUEDE OPERARSE. SIN CONTRAINDICACIONES PARA LA CIRUGIA DE TRASPLANTE. Coronariografía: sin lesiones de arterias coronarias

Historia actual:

Pcte con antecedentes descritos. Traído por familiares a UEA en la tarde del 05/09/2024. Ingres a REANIMACION con compromiso de conciencia:

Fecha Epicrisis : 11/09/2024 20:18

Fecha Última Actualización: 11-09-2024 20:18:01

Página 2 de 3

Esposa refiere cuadro de hematemesis y melena desde las 03 AM. Desde del mediodía cada vez más comprometido de consciencia. Niega fiebre, cefalea, síntomas respiratorios. Últimos 2 días con dolor abdominal y dolor de EEII.

Evaluación primaria:

A: vía aérea permeable, sin signos de trauma supraclavicular

B: ventila simétrico, sin uso de musculatura accesoria

C: llene capilar 5-6 segundos, sin moteado, con melena

D: Glasgow 6 (O1, V1, M4), HGT normal, pupilas isocóricas, mióticas, poco reactivas

E: con melena

Se procede a oxigenoterapia, monitorización, exs, transfusión de GR

Evoluciona en shock hemorrágico, PA 60/30, NAD a 2.5 mcg/kg/min. Se procede a IOT (16 hrs), Etomidato 10 mg + rocuronio 150 mg, segundo intento.

Exs: Ph 6.87, se administra bicarbonato

A las 16:30 hrs presenta nuevamente hipotensión. Se indica 2UGR + 6U PQT, con lo cual mejoran PA y se logra reducir NAD a 0.2 ug/kg/min.

Se solicita EDA de urgencia, la cual se realiza con dificultad para detener sangrado, pero logrando hemostasia. Se suspende terlipresina iniciada en forma empírica por ausencia de várices sangrantes.

èHDA por ulcera bulbo duodenal FORREST I B, resuelta con escleroterapia + hemoclip + hemospray.

Se administran nuevamente de 2UGR y además 6U PFC.

Se presenta paciente a UCI (Dr. Parra), quien acepta cupo, pendiente cama.

Se mantiene manejo de reanimación en UEA, con requerimientos de noradrenalina hasta 0.2 mcg/kg/min para normotensión PAM 87. Normocardico. VMI con TOT 8.0 a 21 cm CM L. Diu por SF, cc/kg/h

Parámetros: FIO2 50% PEEP 6 FR 28 VT 450 Ppico 23

Resumen de manejo UEA:

1. Hemodinamia: shock hemorrágico x HDA, politransfusión en total 6 UI GR + 6 UI PLQ + 6 PFC + Octaplex + ac tranexámico. Con requerimientos de DVA a la baja.

2. Gastro: antecedente de HCC en espera de nueva RM, en lista de trasplante. HDA por ulcera bulbo duodenal FORREST I B, resuelta con escleroterapia + hemoclip + hemospray.

3. Renal/medio interno: cursando AKI con hiperkalemia, sin cambios ECG, con acidosis severa. Se administra HCO 3 + medidas shift.

Pcte ingresa a UCI a las 1:10 am, en malas condiciones generales, sin invasiones, con 4 vvp

Signos clínicos de hipoperfusión, CRT prolongado y Mottling 1

PA x PANI 96/29

Se procede a conectar a monitorización, invadir con LAI (braquial izquierda bajo eco) y CVC YD (bajo eco)

Diagnostico de ingreso:

1. Shock hemorrágico

- HDA ULCERA DE BULBO DUODENAL PROXIMAL, FORREST IB

ESCLEROTERAPIA FRUSTRADA CON EPINEFRINA + HEMOCLIP ¿ HEMOSTASIA CON HEMOSPRAY

VÁRICES ESOFÁGICAS GRANDES CON SIGNOS DE RIESGO, SIN ESTIGMAS DE RUPTURA

2. Antecedentes: hepatocarcinoma en espera de nueva RNM para determinar manejo, DM, HTA, DHC, usuario de NACO (rivaroxabán) por trombosis de arteria hepática

Evolución en UPC cursa con Falla Orgánica Múltiple severa, disfunción circulatoria persistente, disfunción neurológica.

Paciente fallece a las 19:30 h.

Diagnóstico de Egreso

Shock hipovolemico - Hemorragia digestiva alta masiva - Úlcera bulbo duodenal Forrest IB - Disfunción multiorgánica - Hepatitis aguda isquémica - Daño Hepático crónico - Hepatocarcinoma - Hipertensión arterial - Diabetes Mellitus 2

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fecha Epicrisis : 11/09/2024 20:18

Página 2 de 3

Fallece a las 19:30 h

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

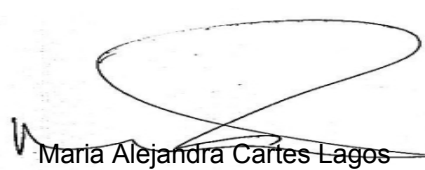
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Maria Alejandra Cartes Lagos
Médico Tratante (Staff)